SDD 84 - Sujet n°2

Spécialité : Dermatologie

Date : 02/01/24
Auteur : Quentin HARDY (ECN 2022, DES Dermatologie)
Relecteur(s) : Robin ELAYLI (ECN 2023, DES Psychiatrie), Clément FILLIOL (ECN 2022, DES Radiologie)

Domaine d'apprentissage principal	Iconographie
Domaine d'apprentissage secondaire	Interrogatoire
Item(s) en lien avec la station	116, 187, 302
Situation(s) de départ en lien avec la station	84 - Lésion cutanée
Matériel nécessaire à la station	Deux pages avec les images imprimées, une table, 2 chaises
Contexte de la station	Vous êtes médecin généraliste lors de votre visite hebdomadaire à l'EHPAD "Les Bourgeons Nouveaux"

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction, même partielle, et toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES Anesthésie-Réanimation, Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES Médecine Interne, Paris), Clément FILLIOL (VP ECOS, DES Radiologie, Lyon) et Alexandre DEGACHI (Président, ancien DES Médecine Interne, Paris)

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :

Vous êtes médecin généraliste. Vous réalisez votre visite hebdomadaire de l'EHPAD "Les Bourgeons Nouveaux". Votre matinée est chargée.

Vous êtes sollicité.e par l'IDE au sujet de Mr JACQUET, 75 ans, pour une plaie de la jambe droite.
Ce patient est atteint d'une démence importante, non étiquetée.

L'IDE a constaté cette plaie (cf image jointe) depuis 4 mois. L'IDE vous sollicite pour le type de pansement à appliquer sur la plaie.
Vous échangez avec l'IDE à ce sujet. Elle a le dossier du patient sous les yeux pour répondre à vos questions.

Consignes :

Vous devez réaliser en 8 minutes, incluant la lecture de ces consignes :

- Analyser l'image fournie
- Réaliser une anamnèse avec l'IDE (uniquement concernant la plaie et la prise en charge dermatologique)
- Évoquer des hypothèses diagnostiques concernant la plaie, et une proposition pour étayer ce diagnostic

Vous ne devez pas :

- Réaliser l'examen clinique (hors analyse iconographique)

Attention : Vous avez 8 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction, même partielle, et toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES Anesthésie-Réanimation, Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES Médecine Interne, Paris), Clément FILLIOL (VP ECOS, DES Radiologie, Lyon) et Alexandre DEGACHI (Président, ancien DES Médecine Interne, Paris)

ECOS TACFA

GRILLE D'ÉVALUATION

Aptitudes cliniques			
Partie I : Description lésionnelle			
1.	Croûte nécrotique	1 pt	☐
2.	Peu de relief	1 pt	☐
3.	Bords nets	1 pt	☐
4.	Berges peu inflammatoires	1 pt	☐
Partie II : Anamnèse complémentaire			
5.	Recherche des antécédents carcinologiques cutanés personnels	1 pt	☐
6.	Recherche une exposition solaire importante passée (ponctuelle ou chronique)	1 pt	☐
7.	Recherche une altération de l'état général : perte de poids ET fatigue ET anorexie	1 pt	☐
8.	Précise le contexte de survenue de la plaie	1 pt	☐
9.	Précise l'évolutivité de la plaie	1 pt	☐
10.	Interroge sur les topiques appliqués	1 pt	☐
11.	Interroge sur la symptomatologie en rapport avec la plaie : recherche de **douleur**	1 pt	☐
12.	Interroge sur la symptomatologie en rapport avec la plaie : recherche de **prurit**	1 pt	☐
13.	Demande si la plaie est hémorragique et/ou exsudative	1 pt	☐
Partie III : Hypothèse diagnostique			
14.	Évoque une étiologie possible carcinomateuse à la plaie	1 pt	☐
15.	Recherche des arguments clinico-anamnestiques en faveur d'un ulcère artériel ET les arguments en faveur d'un ulcère veineux	1 pt	☐
16.	Propose un contrôle histologique de la plaie (biopsie cutanée ou exérèse d'emblée, les deux étant possibles ici)	1 pt	☐

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction, même partielle, et toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES Anesthésie-Réanimation, Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES Médecine Interne, Paris), Clément FILLIOL (VP ECOS, DES Radiologie, Lyon) et Alexandre DEGACHI (Président, ancien DES Médecine Interne, Paris)

Communications et attitudes	
17.	**6. COMMUNICATION AVEC LES PAIRS (clarté de communication)**

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Est incapable de communiquer le message	Est capable de communiquer les principaux messages, n'arrive pas à les justifier	Est capable de communiquer les principaux messages et justifier son raisonnement	Communique les informations pertinentes et les justifie. Ne s'attarde pas à de l'information inutile	Relie les informations provenant des domaines différents faisant preuve d'une maîtrise du sujet

18.	**8. APTITUDE À FAIRE LA SYNTHÈSE DES DONNÉES**

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
N'arrive pas à faire ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème	Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème quelquefois sans les justifier	Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème et justifie son raisonnement	Fait ressortir les éléments positifs et négatifs pour clarifier le problème et justifie son raisonnement	Agit avec assurance et sans erreur

TOTAL	/ 18 points

<u>Éléments de rétroaction</u> :

Il n'est pas rare, derrière une sollicitation banale (quel pansement pour une plaie), de découvrir quelque chose qui l'est moins (une suspicion de cancer cutané ici).

Il importe donc d'être vigilant.

Une plaie qui ne guérit pas après environ 1 mois est suspecte. Surtout chez un patient dément avec des circonstances d'apparition floues.

Il n'y a probablement ici jamais eu de coup reçu, mais directement un cancer prenant l'aspect d'une plaie.

(Pour information, cette image est celle d'un patient vu en consultation pour exérèse d'un CBC du dos, avec découverte fortuite à l'examen systématique de cette "plaie", qui s'est révélée être un CBC superficiel à la biopsie cutanée).

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction, même partielle, et toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES Anesthésie-Réanimation, Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES Médecine Interne, Paris), Clément FILLIOL (VP ECOS, DES Radiologie, Lyon) et Alexandre DEGACHI (Président, ancien DES Médecine Interne, Paris)

ECOS TACFA

SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour l'IDE :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal »

Rappel du scénario du candidat :

Vous êtes un.e médecin généraliste qui réalisez votre visite hebdomadaire de l'EHPAD "Les Bourgeons Nouveaux". Votre matinée est chargée.

Vous êtes sollicité.e par l'IDE au sujet de Mr JACQUET, 75 ans, pour une plaie de jambe droite.

Ce patient est atteint d'une démence importante, non étiquetée.

L'IDE a constaté cette plaie (cf image jointe) depuis 4 mois. L'IDE vous sollicite pour le type de pansement à appliquer sur la plaie.

Vous échangez avec l'IDE à ce sujet.

Plan de la station ECOS :

L'IDE est debout dans le poste de soins. Le médecin est également debout. Une image de la plaie est posée sur le poste de travail du poste de soins.

Le patient n'est pas présent.

<u>Phrase de démarrage de l'IDE simulée (par <3) :</u>

Bonjour Docteur. Merci de passer !

Je suis embêtée par une plaie de jambe de Mr JACQUET.

Je l'ai vue par hasard il y a environ 4 mois. Elle ne guérit pas, malgré tous mes pansements essayés.

Je l'ai prise en photo hier, avec un gros plan avec le dermatoscope qui traînait sur une étagère !

Identité du patient :

Mr JACQUET, 75 ans, IMC 19 kg/m2.

Mode de vie :

En EHPAD depuis 2 ans. GIR 2. Ancien agriculteur (exposition solaire importante).

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales

Toute reproduction, même partielle, et toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.

Sous la supervision de Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES Anesthésie-Réanimation, Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES Médecine Interne, Paris), Clément FILLIOL (VP ECOS, DES Radiologie, Lyon) et Alexandre DEGACHI (Président, ancien DES Médecine Interne, Paris)

Comportement global :

L'IDE est bienveillante, soucieuse de guérir la plaie de Mr JACQUET

Antécédents personnels :

- Carcinome épidermoïde du cuir chevelu d'exérèse complète en 2020.
- Démence non étiquetée.
- FA anticoagulée.
- HTA.
- Un doppler veineux et artériel il y a 1 ans : aucune AOMI ni insuffisance veineuse significative.

Antécédents familiaux :

Non connus

Médicaments :

- ELIQUIS 5 mg matin et soir
- FUROSÉMIDE 20 mg : 1 cp matin

Symptômes positifs :

Le patient assure que sa plaie résulte d'un coup dans un meuble, sans que l'équipe ait pu confirmer.

Le patient ne se plaint de rien. Pas d'altération de l'état général.
D'après l'IDE, la plaie est superficielle, sans induration en profondeur.

La plaie est à peu près identique depuis 4 mois. Un peu de saignement quand le patient la gratte.

Pansements essayés, sans succès : hydrocolloïdes, interface grasse, alginate.

Pas de topique particulier appliqué hormis crème hydratante.

Constantes :

Sans particularité.

Donnée complémentaire :

Les iconographies en annexe (dernières pages)

Questions de relance :

À 6 minutes : " Dites-moi Docteur, sa plaie va finir par cicatriser ?"

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction, même partielle, et toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES Anesthésie-Réanimation, Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES Médecine Interne, Paris), Clément FILLIOL (VP ECOS, DES Radiologie, Lyon) et Alexandre DEGACHI (Président, ancien DES Médecine Interne, Paris)

ECOS TACFA
FEUILLET ORGANISATEUR

Plan de la station ECOS :

Le généraliste et l'IDE sont debouts dans le poste de soin. Les 2 images de la plaie sont posées sur la table du poste de soins.

Matériel nécessaire à la station :

- IPAD pour examinateur
- Feuille de brouillon pour candidat
- Stylo pour candidat
- Feuille de brouillon pour évaluateur
- Stylo pour évaluateur

Documents présents dans la station :

- Feuilles d'évaluation de papier de secours
- Les 2 images (imprimées ou sur tablette)

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction, même partielle, et toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES Anesthésie-Réanimation, Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES Médecine Interne, Paris), Clément FILLIOL (VP ECOS, DES Radiologie, Lyon) et Alexandre DEGACHI (Président, ancien DES Médecine Interne, Paris)

ECOS TACFA
ICONOGRAPHIE N°1

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales

Toute reproduction, même partielle, et toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.

Sous la supervision de Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES Anesthésie-Réanimation, Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES Médecine Interne, Paris), Clément FILLIOL (VP ECOS, DES Radiologie, Lyon) et Alexandre DEGACHI (Président, ancien DES Médecine Interne, Paris)

ECOS TACFA
ICONOGRAPHIE N°2

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales

Toute reproduction, même partielle, et toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.

Sous la supervision de Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES Anesthésie-Réanimation, Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES Médecine Interne, Paris), Clément FILLIOL (VP ECOS, DES Radiologie, Lyon) et Alexandre DEGACHI (Président, ancien DES Médecine Interne, Paris)